

Faculté de Médecine de Sousse
Diabète sucré : Première Partie
Préparation au concours de Résidanat 2025

Question 1

Le dépistage du diabète est indiqué devant :

- A. Un syndrome poluro-polydipsique
- B. Un bilan d'embauche
- C. Une rétinopathie
- D. Une HTA
- E. Âge > 35 ans

Question 2

Le diabète de type 2 peut être précédé par :

- A. Une HTA
- B. Les anticorps anti-pancréas
- C. Un IDM
- D. Un diabète gestationnel
- E. Une rétinopathie

Question 3

Le déclin de la cellule bêta dans le diabète de type 2 est en rapport avec :

- A. Le déséquilibre prolongé du diabète
- B. Une destruction auto-immune des cellules bêta
- C. Des poussées de pancréatite
- D. Une lipotoxicité
- E. Une mutation de la glucokinase

Question 4

Parmi les diabétiques, le diabète de type 1 représente :

- A. 5%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 20%
- E. 25%

Question 5

Le taux d'hémoglobine glyquée peut être faussé dans le diagnostic de diabète par :

- A. L'obésité
- B. L'insuffisance rénale chronique
- C. L'insuffisance hépatique chronique
- D. L'âge > 65 ans
- E. La thalassémie

Question 6

Le prédiabète au cours du diabète de type 2 :

- A. Nécessite le recours à une HGPO
- B. Est réversible
- C. Nécessite la prescription de médicaments
- D. Expose à un risque vasculaire
- E. S'accompagne d'un syndrome polyuro-polydipsique

Question 7

Pour confirmer la nature auto-immune d'un diabète sucré, vous demandez le dosage des anticorps :

- A. Anti-GAD
- B. Antigliadine
- C. Anti-ICA
- D. Anti-Zinc T8
- E. Anti-insuline

Question 8

Un diabète de type 1 est dit lent lorsque son état ne nécessite pas le recours à l'insuline après au moins :

- A. 3 mois
- B. 6 mois
- C. 9 mois
- D. 12 mois
- E. 18 mois

Question 9

Chez un patient âgé de 60 ans, IMC 21 Kg/m², un diabète révélé par un syndrome polyuro-polydipsique et un amaigrissement sans antécédents familiaux. Les anticorps sont négatifs. Il faut évoquer :

- A. Un diabète pancréatique
- B. Un diabète de type 2
- C. Un diabète de type 1 lent
- D. Un diabète monogénique
- E. Un diabète mitochondrial

Question 10

Un diabète pancréatique est évoqué devant :

- A. Un amaigrissement important
- B. L'association à une HTA
- C. Le terrain éthylique
- D. Un terrain polytransfusé
- E. Un terrain auto-immun

Question 11

Les maladies endocriniennes entraînant un diabète sucré sont :

- A. Le syndrome de Cushing
- B. Le phéochromocytome
- C. L'acromégalie
- D. L'hyperaldostérionisme secondaire
- E. L'hyperthyroïdie

Question 13

Les facteurs de risque de diabète gestationnel sont :

- A. Âge maternel > 30 ans en général
- B. Âge maternel > 25 ans si hérédité au 1er degré
- C. BMI > 30 kg/m²
- D. Prise de poids excessive au cours de la grossesse
- E. ATCD de toxémie gravidique

Question 14

Le diabète mitochondrial se caractérise par :

- A. Une transmission autosomique dominante
- B. Une surdité de perception
- C. Une hyperglycémie bénigne familiale
- D. Une insulino-résistance sévère
- E. Une atteinte psychiatrique associée

Question 15

Le diabète MODY est évoqué devant :

- A. Âge < 25 ans
- B. Transmission sur 3 générations
- C. Cas féminins les plus touchés
- D. Auto-immunité anti-pancréatique négative
- E. Surdité néonatale

Question 16

Un coma hypoglycémique chez un diabétique âgé traité par des antidiabétiques oraux justifie :

- A. L'injection immédiate de Glucagon
- B. L'injection intraveineuse de sérum glucosé à 30%
- C. L'arrêt définitif d'un traitement par les sulfamides
- D. L'arrêt définitif d'un traitement par la metformine
- E. La réévaluation de sa fonction rénale

Cas clinique 1: Lors d'un examen biologique à jeun, un patient âgé de 32 ans trouve une glycémie à 1,32 g/l. il n'a pas de plaintes. Il a un IMC à 32, un tour de taille de 102 cm, une TA à 150/100 mmHg, un acanthosis nigricans.

Question 17

Pour vérifier le diagnostic de diabète vous demandez :

- A. Une autre glycémie à jeun
- B. Une HGPO

- C. Une HbA1c
- D. Une glycémie post-prandiale
- E. Une glycosurie

Question 18

Dans le cadre de l'exploration initiale d'un diabète, vous réalisez :

- A. Un dosage de TSH
- B. Un bilan lipidique
- C. Une micro-albuminurie
- D. Un EMG
- E. Un fond d'œil

Cas clinique 2 : Un patient de 32 ans présente un syndrome polyuro-polydipsique évoluant depuis 9 mois avec un amaigrissement chiffré à 6 Kg. Il rapporte que sa sœur est hypothyroïdienne et que ses parents ne sont pas diabétiques. Il ne boit pas d'alcool. Son IMC est à 28 ; tour de taille : 92 cm ; TA : 120/80 mmHg

Glycémie à jeun : 13 mmol/l ; acétonurie : négative ; anticorps anti GAD et antiperoxydase positifs; antigliadine, cellules pariétales gastriques et anti 21 hydroxylase négatifs

19. Le diagnostic de diabète chez ce patient :

- A. Nécessite une autre glycémie à jeun
- B. Est retenu
- C. Nécessite le dosage de l'HbA1c
- D. Nécessite une HGPO
- E. Nécessite le dosage de l'insulinémie

20. Vous retenez chez ce diabétique le diabète de type :

- A. DT2
- B. DT1 aigu
- C. DT1 lent
- D. Pancréatique
- E. Monogénique

21. L'exploration de ce patient permet de suspecter l'installation prochaine de :

- A. Maladie d'Addison
- B. Vitiligo
- C. Maladie cœliaque
- D. Anémie de Biermer
- E. Thyroïdite de Hashimoto

Cas clinique 3 : Un diabétique âgé de 52 ans tabagique et consommateur d'alcool consulte pour des paresthésies des pieds empêchant le patient de dormir depuis 15 jours ; il signale également une dysfonction érectile et des malaises fréquents non calmés par les repas. Son examen montre : IMC : 32 ; TA : 140/80 mmHg couché et 110/70 mm Hg debout ; loge thyroïdienne libre ; réflexes achilléens abolis ; pouls périphériques perçus ; fond d'œil normal

Son exploration montre : HbA1c : 9,5%, glycémie à jeun : 15 mmol/l ; acétonurie : négative ; ECG normal ; microalbuminurie : 25 mg/j ; clearance créatinine : 90 ml/mn ; échographie abdominale normale.

22. Ce patient présente :

- A. Un diabète pancréatique
- B. Un diabète de type 2
- C. Un diabète ancien
- D. Un diabète de type 1
- E. Un prédiabète

23. Ce diabète est compliqué de :

- A. Polynévrite
- B. Neuropathie autonome
- C. Néphropathie
- D. Rétinopathie
- E. Coronaropathie

24. Ce patient nécessite la prescription de :

- A. Antihypertenseurs
- B. Prégabaline
- C. Insulinothérapie intensive
- D. Sulfamides
- E. Analogues de GLP-1

Cas clinique 4 : Une patiente âgée de 27 ans, consulte à 24 semaines d'aménorrhée avec le résultat de l'HGPO-75g. Sa mère est diabétique de type 2. Elle est G2P1 ; son enfant, âgé de 2 ans, était macrosome. Son IMC était de 27 Kg/m² avant la grossesse.

Sa glycémie à jeun au 1er trimestre était de 0,91 g/l. Ses glycémies lors de l'HGPO :

H0 = 0,94 g/l,

H1 = 1,74 g/l,

H2 = 1,6 g/l.

Son HbA1c est de 5,6%.

25. Vous retenir un diabète gestationnel devant :

- A. Sa glycémie à jeun au 1er trimestre
- B. Sa glycémie à H0 lors de l'HGPO
- C. Sa glycémie à H1 lors de l'HGPO
- D. Sa glycémie à H2 lors de l'HGPO
- E. Le taux de son HbA1c

26. On considère comme facteur de risque du diabète gestationnel chez cette patiente:

- A. Âge maternel
- B. Antécédents familiaux
- C. Antécédents personnels
- D. Son indice de masse corporelle
- E. Prédiabète avant la grossesse

27. Cette patiente est exposée au cours de cette grossesse à :

- A. Malformation fœtale
- B. Macrosomie fœtale
- C. Toxémie gravidique
- D. Néphropathie diabétique
- E. Accouchement prématuré

Cas clinique 5 : Une jeune femme de 22 ans consulte pour une asthénie et un syndrome polyuro-polydipsique apparus 3 semaines après une infection par le COVID-19. A l'examen : elle est fatiguée et a des cernes oculaires. Poids : 45 kg, Taille : 162 cm, bandelettes urinaires : glucose +++ acétone 0. Sa glycémie est à 4,5 g/l.

28. Vous suspectez un diabète type 1, quels sont les anticorps à demander pour le confirmer :

- A. Anti transporteur du zinc (ZnT8)
- B. Anti gliadine

- C. Anti glutamate acide décarboxylase (GAD)
- D. Anti IA2
- E. Anti thyroperoxydase

29. Après sa mise sous traitement, l'éducation de cette patiente portera sur :

- A. La planification de grossesse
- B. La perte de poids
- C. Les hypoglycémies
- D. L'interdiction du jeûne du mois de ramadan
- E. L'autosurveillance glycémique

Cas clinique 6 : Mr S âgé de 72 ans, est ramené aux urgences au mois d'Août dans un tableau de déshydratation globale avec coma. L'interrogatoire de son fils révèle qu'il est hypertendu depuis 2 ans sous captopril (Lopril®50) : 2 cp/j. Il n'est pas connu diabétique. Il a maigri au cours des dernières semaines.

A l'examen : Glasgow à 12, langue sèche, pli cutané persistant, température : 38,5°C, TA : 10/6 cm Hg, pouls : 110/mn, pas de dyspnée, abdomen souple, non douloureux.

Glycosurie : ++++, acétonurie : 0, leucocyturie : +++, nitrites : +++.

Biologie : glycémie : 45 mmol/l, créatinine : 190 µmol/l, urée : 16 mmol/l, natrémie : 143 mmol/l, kaliémie : 4,3 mmol/l. ECG : rythme sinusal régulier à 110 cycles/minutes. Radiographie du thorax normale.

Vous suspectez un coma hyperosmolaire.

30. Chez ce patient, cette complication a été favorisée par :

- A. L'âge du patient
- B. La saison chaude
- C. Le diabète méconnu
- D. Une infection
- E. La prise de captopril

31. La prise en charge en urgence de ce patient repose sur :

- A. La réhydratation par sérum physiologique à 9 ‰
- B. L'administration d'insuline intermédiaire par voie intraveineuse
- C. Une antibiothérapie
- D. L'administration de bicarbonates intraveineux
- E. L'administration d'héparine de faible poids moléculaire

32. La prévention future de cette complication chez ce patient reposera sur :

- A. L'introduction précoce de l'insulinothérapie en cas de déséquilibre glycémique
- B. L'implication de l'entourage dans la prise en charge du patient
- C. L'apport régulier d'eau
- D. L'arrêt du captopril
- E. Le choix d'un objectif d'Hb1Ac à 6,5%

Cas clinique 7 :

La patiente MA , âgée de 22 ans est diabétique de type 1 depuis 8 ans. Elle est sous insuline Glargine 22 ui le soir et insuline Aspart 8 ui à chaque repas. Elle est hospitalisée pour des pertes de connaissances, aux urgences la GAD = 0.32 g/l. Le diagnostic d'hypoglycémie grave est retenu.

1/ une hypoglycémie grave est retenue devant :

- A. Le taux de glycémie au doigt < 0.4 g/l
- B. L'absence de signes annonciateurs
- C. Le recours à une tierce personne pour le resucrage
- D. La survenue chez un diabétique de type 1
- E. La survenue sous insuline

2/ la conduite à tenir en urgence doit comporter :

- A. Un resucrage par 15g de sucre per os
- B. Une injection d'une ampoule de glucagon
- C. La perfusion de sérum physiologique
- D. L'administration de 2 ampoules G30% en IVD
- E. L'arrêt de l'insuline basale

3/ l'enquête étiologique comporte :

- A. La recherche de lipodystrophies

- B. L'arrêt de l'insuline
- C. La recherche d'hypothyroïdie
- D. La recherche de rétinopathie diabétique
- E. Un bilan de malabsorption

Cas clinique 8 :

Mr KB 78 ans est diabétique depuis plus de 20 ans traité par Metformine et gliclazide. Il est retrouvé en mois de Juillet, chez lui dans un état de confusion. Il vit seul depuis le décès de sa femme. Sa fille rapporte qu'il était très fatigué et désorienté les derniers jours. Elle a aussi noté qu'il buvait énormément d'eau, allait fréquemment uriner et qu'il avait perdu de poids ces dernières semaines. Il est également suivi pour hypertrophie bénigne de la prostate et HTA sous Candésartan, amlodipine et furosémide.

**A l'examen : Glasgow 13/15 ; TA = 100/60 mmHg ; Fc = 110 bpm ; muqueuses sèches, pli cutané persistant. Pas de signes neurologiques de localisation.
a la biologie : Glycémie = 39 mmol/l ; Na⁺ = 160 mmol/l ; K⁺ = 4 mmol/l ; urée = 22 mmol/l ; créatinine = 180 µmol/l ; osmolarité plasmatique = 360 mosmol/kg. pH = 7.38 ; HCO₃⁻ = 22 mmol/l ; BU= Au + GU ++++ nitrites +**

1/ un coma hyperosmolaire est retenu devant :

- A. Glycémie > 33 mmol/l
- B. Glucosurie fortement positive
- C. pH neutre
- D. osmolarité plasmatique
- E. troubles de la conscience

2/ Vous incriminez comme facteurs déclenchant :

- A. l'infection urinaire
- B. la chaleur
- C. l'âge
- D. la prise de diurétique
- E. la metformine

3/ la prise en charge de notre patient comporte :

- A. l'insulinothérapie continue en IV à la dose de 0.1U/kg/h
- B. la réhydratation en IV
- C. la prescription d'HBPM

- D. l'arrêt de la Metformine
- E. l'augmentation de la dose de gliclazide